

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE KLINIKUM KATZENBUCH
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 26	Bezeichnung des Dokumentes: Pflege und Betreuung beatmungspflichtiger Patienten	

Durchführende:

- Pflegefachkräfte (PFK)

Qualifikation:

- Ausbildung Gesundheits- und Krankenpfleger/in bzw. Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in (bei unter 18jährigen Patienten)
- Fachpflegekraft für Anästhesie und Intensivpflege
- Atmungstherapeut
- mindestens ein Jahr Berufserfahrung im Beatmungsbereich in den letzten 5 Jahren
- mindestens 120 Stunden Fortbildung gemäß den Anforderungen der DIGAB-Zertifizierung
- jährliche Fortbildungen zu den Themen „Reanimation“ und „Erste Hilfe“

Kooperationsbeziehungen:

Unsere Einrichtung arbeitet eng mit einem Beatmungszentrum, Krankenhaus oder in der außerklinischen Beatmung erfahrenen Arzt zusammen. In der Patientendokumentation werden diese Kontaktdaten im Stammbblatt dokumentiert. Ebenso finden sich hier Kontaktdaten externer Supportunternehmen (Homecare – Unternehmen).

Ziele der Maßnahme:

- Förderung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens
- Sicherung adäquater Versorgung mit Atemluft,
- Sicherung sekretfreier Atmung,
- Vermeidung von Aspiration und Infektion
- Schutz der Atemwege des Patienten
- Erhaltung der Kommunikationsfähigkeiten des Patienten

Indikation:

- nur auf ärztliche Anordnung
- beatmungspflichtige Patienten bzw. Patienten mit respiratorischer Insuffizienz bspw. COPD-Patienten, Querschnittsgelähmte, Patienten mit Apallischem Syndrom (Wachkoma), Patienten mit Tumorerkrankungen, Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma oder anderen neurologischen Erkrankungen, Bewusstlosigkeit/Koma, Patienten mit Herz-Rhythmusstörungen oder Störungen im Flüssigkeits-, Elektrolyt-, Säure- und/oder Basenhaushalt etc.

Kontraindikation:

- bei Ablehnung des Patienten
- bei Komplikationen, dann ist es ausschließliche Aufgabe des Arztes die weitere Vorgehensweise/ Therapie zu bestimmen

Vorbereitung:

- Hände waschen und desinfizieren
- Patienten informieren
- Patienten flach hinlegen lassen
- Materialien für die Pflegemaßnahmen bereitlegen

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE FÜR ALLE BEATMUNGSPFLEGER
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 26	Bezeichnung des Dokumentes: Pflege und Betreuung beatmungspflichtiger Patienten	

Material:

- Hände- und Flächendesinfektionsmittel
- Einmalhandschuhe (steril, unsteril)
- Kanüle mit Cuff
- Schlitzkompressen, Kanülenhalteband
- Stomapflegeöl, Kompressen, Reinigungspulver, Reinigungsbürste, Abdecktuch für Tracheostoma,
- Material zur endotrachealen Absaugung, Absauggerät
- Abwurfbehälter, Hautdesinfektionssmittel, Zellstoff

Achtung!

- Wichtig sind gute psychische Betreuung um Angstzustände zu vermeiden,
- Logopädie sollte berücksichtigt werden: Ersatzsprache, Umgang mit Sprachapparat bzw. Sprechkanüle
- Bei Vorliegen von Hinweisen auf eine klinische Verbesserung bei der beatmeten Person ist der entsprechende Kooperationspartner zu informieren um das Dekanülierungspotential und/ oder Weaningpotential (Entwöhnung) zu bewerten und das weitere Vorgehen festzulegen.
- Tracheostoma immer mit Abdecktuch bedecken
- Es sind Angaben zur Indikation der Trachealkanüle, Form der Tracheostomaanlage, zu Kanülentyp und -größe, alle Hilfsmittel, Angaben zum Wechsel der Kanüle (Häufigkeit, Art und Weise der Durchführung, berechtigter Personenkreis und die regelmäßigen Cuff-Druck-Messungen zu dokumentieren
- Notfall: Kanüle entfernen, griffbereite Ersatzkanüle einsetzen (in der Regel eine Nummer kleiner als die reguläre Kanüle) – Arzt informieren
- Absaugen des Sekretes je nach Notwendigkeit (mindestens 1 x pro Schicht, nicht länger als 15 Sekunden), nur solange absaugen wie man Luft anhalten kann, immer einen neuen Absaugkatheter verwenden, Sekretbehälter bei Bedarf wechseln
- der Sammelbehälter ist zu desinfizieren, im Sammelbehälter ist Desinfektionsflüssigkeit beizumengen
- Beachte unbedingt Maßnahmen zur Vorbeugung/Prävention gegen Pilzinfektionen in der Mundschleimhaut, Entzündungen der Ohrspeicheldrüse und Pneumonieprophylaxe
- die Beatmungsmodus, Beatmungsparameter, Beatmungsdauer sowie Dauer möglicher Spontanatmung müssen dokumentiert sein
- die Vitalparameter (auch Schwellenwerte) sind zu dokumentieren
- bei Abweichungen bzw. notwendigen Veränderungen und Notfällen ist immer der Arzt hinzuzuziehen
- jeder Mitarbeiter ist in die richtige Bedienung und Handhabung des Gerätes nach MPG/MBetreiberV eingewiesen, die Hinweise der Hersteller sind zu beachten
- notwendige Hilfsmittel sind zu dokumentieren
- Wechsel- und Reinigungsintervalle sind festzulegen, bei Notwendigkeit ist sich mit dem Arzt bzw. Hersteller abzustimmen

Endotracheales Absaugen über die Trachealkanüle

Durchführung:

- Einsichtnahme in die Dokumentation
- Oberkörper hoch lagern

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE FÜR ALLE IN DEN KRANKENHAUSEN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 26	Bezeichnung des Dokumentes: Pflege und Betreuung beatmungspflichtiger Patienten	

- während der gesamten Maßnahme des Absaugens den Patienten beobachten
- Hände waschen und desinfizieren, Einmalhandschuhe anziehen
- beim Absaugen mit Absaugsystemen sind im Rahmen der Beatmung sterile Einmalhandschuhe zu verwenden
- Steril verpackte Absaugkatheter öffnen und ohne Sog bis vor die Carina einführen (Carina tracheae bezeichnet den durch den untersten Trachealknorpel gebildeten Sporn), „Finger-Tip“ nutzen (nie gegen Widerstand arbeiten, kein Stochern, kein Festsaugen)
- Absauggerät gemäß Herstellerangaben verwenden
- Vorsichtiges zurück ziehen des Absaugkatheters (max. 15 s Absaugen)
- zuerst Trachealabsaugung dann Umgebungsgebiet der Trachealkanüle absaugen
- Entsorgung von Katheter und Einmalhandschuhe
- Die Beschaffenheit des Sekrets ist zu beurteilen, das Ergebnis ist zu dokumentieren
- Sekretbehälter mehrmals täglich leeren
- Sekretbehälter nie mehr als 1/4 - 1/3 Füllstand
- Absauggerät entsprechend der Herstellerangaben desinfizieren
- Einhaltung von Hygienegrundsätzen im Sinne der Empfehlung des Robert-Koch-Institutes (RKI) „Prävention der nosokomialen beatmungsassoziierten Pneumonie“

Umgang mit Beatmungsgeräten

- bei Übernahme und im laufenden pflegerischen Geschehen - Anpassung und Überprüfung des Beatmungsgerätes in Hinblick Einstellungen der Vitalparameter (bspw. Atemgase, Herzfrequenz, Blutdruck) lt. Ärztlicher Anordnung
- ständige Funktionsprüfung des Beatmungsgerätes
- ggf. Austausch bestimmter Geräteteile (Beatmungsschläuche, Kaskaden - Befeuchter, O2-Zellen) gemäß Herstellerangaben
- Beatmungsparameter und –messwerte mindestens 1 x pro Schicht dokumentieren und kontrollieren ob diese mit den Einstellungen am Beatmungsgerät übereinstimmen
- erforderliche Hilfsmittel zur Durchführung einer maschinellen Beatmung sind dokumentiert, ebenso Wechsel- und Reinigungsintervalle

Besondere Anforderungen an die Geräteausstattung bei nicht invasiv/ invasiv Beatmeten

- ein manueller Beatmungsbeutel (Ambubeutel) einschließlich Maske ist Patienten nah vorzuhalten
- externer Akku für ein Beatmungsgerät ist ständig betriebsbereit mit einer Kapazität von mindestens 8-10 Stunden vorzuhalten, wenn bei der versorgten Person die Spontanatmungsfähigkeit zeitlich stark reduziert ist (tägl. Beatmungszeit von mehr als 16 Stunden), ebenso ein zweites Beatmungsgerät (bei einer tägl. Beatmungszeit von mehr als 16 Stunden)
- bei mobilen Patienten, welche einen Rollstuhl verwenden, ist ebenso ein zweites Beatmungsgerät erforderlich. Beide Beatmungsgeräte sind in Geräteeinstellung identisch
- bei nicht invasiv beatmeten Personen mit Maskenbeatmung ist eine Reservemaske in der gleichen Größe vorzuhalten
- bei invasiv beatmeten Patienten ist ein zweites Absauggerät vorhanden, welches netzunabhängig betrieben werden kann.
- Dokumentation und Überprüfung der Einsatz- und Ersatzgeräte auf Funktion und Richtigkeit der aktuellen Beatmungsparameter

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	3	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE VON WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN BERATERN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 26	Bezeichnung des Dokumentes: Pflege und Betreuung beatmungspflichtiger Patienten	

Sachgerechter Umgang mit Beatmungspflichtigen:

- Einsichtnahme in die Dokumentation
- Durchführung von Pflegemaßnahmen im Rahmen der Beatmung insbesondere Befeuchtung der Mund- und Schleimhäute
- Vermeidung von Druckstellen durch Tuben/ Beatmungszugänge und ableitende Systeme
- bei anderen pflegerischen Auffälligkeiten Beratung von Angehörigen
- bei Notwendigkeit und nach genehmigter ärztlicher Verordnung Umsetzung weiterer pflegerischer Maßnahmen gemäß für uns festgelegter weiterer Pflegestandards

Wechseln der Trachealkanüle

Durchführung:

- Einsichtnahme in die Dokumentation
- Während der gesamten Maßnahme des Wechsels Patienten beobachten
- Hände waschen und desinfizieren, sterile Einmalhandschuhe anziehen
- Vor dem Wechsel der Kanüle nochmals absaugen
- Haltebänder lösen, Cuff entblocken
- Kanüle gemäß physiologischem Bogen herausziehen
- Darauf achten, dass der Hustenreiz zu unkalkulierbaren Bewegungen seitens des Patienten führen kann
- Umgebung des Tracheostoma vorsichtig mit fusselfreier Kompresse reinigen und desinfizieren (nichts darf in das Stoma gelangen)
- Sekretabsonderungen mit Stomapflegeöl und Kompresse entfernen
- Neue Trachealkanüle mit Stomapflegeöl einreiben, Schlitzkompressen anbringen
- Halteband unter dem Nacken anbringen
- Kopf zurück neigen, vorsichtiges Einführen der Kanüle und Rückwärtsbewegung des Kopfes in Normalstellung
- Cuff wieder blocken
- zu dokumentieren sind mindestens folgende Angaben: Indikation der Trachealkanülenanlage, Art der Tracheostoma-Anlage, Kanülentyp, Kanülengröße, alle im Zusammenhang mit der Trachealkanüle eingesetzten Hilfsmittel, zum Wechsel der Trachealkanüle (Häufigkeit, Art und Weise der Durchführung), wer den Kanülenwechsel durchführt, ggfls. regelmäßige Cuff-Druck-Messungen

Pflege eines Tracheostoma

Durchführung:

- Während der gesamten Maßnahme der Pflege Patient beobachten
- Pflege mindestens 1 x pro Schicht
- Hände waschen und desinfizieren, Einmalhandschuhe anziehen
- Entfernen der alten Schlitzkompressen und Verwerfen
- Inspektion der Trachea

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	4	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE SEIT 1978
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 26	Bezeichnung des Dokumentes: Pflege und Betreuung beatmungspflichtiger Patienten	

- Reinigung des Tracheostoma und der Umgebung //(aseptischer Verbandswechsel – entzündungsfrei / septischer Verbandswechsel – entzündet) mit sterilen Kompressen und Schleimhautdesinfektionsmittel
- Je nach Einwirkzeit (60 Sekunden) neue sterile Schlitzkomresse unterlegen
- Bei Notwendigkeit Kanülentrageband erneuern
- Patient nach Abschluss der Maßnahmen bequem lagern

Spezielle Krankenbeobachtung:

- Einsichtnahme in die Dokumentation
- Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt durch eine Pflegefachkraft mit den geforderten Qualifikationen über 24h
- Nachweis das die erbrachte Leistung der ärztlichen Verordnung entspricht
- Kontinuierliche Beobachtung, ständige Interventionsbereitschaft, Vitalzeichenkontrolle und deren Dokumentation sicherstellen
- Schwellenwerte von Vitalparametern sind dokumentiert, bei denen weiter pflegerische bzw. behandlungsrelevante Interventionen erfolgen müssen
- Korrekte Dokumentationen von Alarmgrenzen der ärztlich angeordneten transdermalen Sauerstoffsättigungsmessung
- Verlaufskontrollen bezüglich Vitalparameter und –funktionen (Puls, Temperatur, Haut und Schleimhäute) durchgeführt und dokumentiert
- Verlaufskontrollen hinsichtlich Bewusstseinszustand, Beobachtung auf Ödeme, Schlafqualität, O2-Befeuchtung, Körpergewicht, Muskulatur, Bilanzierung durchgeführt und dokumentiert
- Blutdruckmessung
- ggf. Blutzuckermessung
- nur nach ärztlicher Anordnung dürfen Veränderungen am Beatmungssystem oder der Einstellung vorgenommen werden

Nachbereitung:

- Händedesinfektion
- Abfall entsorgen
- Dokumentation der Leistungsdurchführung, bei Notwendigkeit Anpassung der Maßnahmeplanung
- Dokumentation aller Auffälligkeiten des körperlichen und seelischen Zustands oder Verweigerungen von Pflegemaßnahmen
- bei erheblichen Abweichungen und Auffälligkeiten Information an die PDL bzw. an die diensthabende Fachbereichsleitung bzw. Teamleitung
- Der Patient ist in die „Übersicht von Patienten mit pflegerischen Besonderheiten“ (Fundstelle I.3 QM-Handbuch) aufzunehmen

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	5	Verw./MA